

L'APPROCHE EN ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE :

Bases théoriques et processus de réflexion

GJIKA Ergys

Service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil locomoteur
Hôpitaux Universitaires de Genève

PLAN DE REFLEXION

0. GENERALITEES (4 QCM)

- Ostéoporose
- Complications en orthopédie
- Gestion de la cicatrisation

1. PEDIATRIE (2 QCM)

- Boiterie
- Néoplasie

2. RACHIS (1 QCM)

3. MEMBRE SUPERIEURE (8 QCM)

- Main, poignet, avant bras
- Coude, humérus, épaule

4. MEMBRE INFERIEURE (8 QCM)

- Bassin, hanche, fémur
- Genou, tibia
- Cheville, pied

5. TRANSVERSALE (6 QCM)

0. GENERALITEES : Ostéoporose

0.1 Madame H. se présente à votre consultation de rhumatologie, elle veut comprendre pourquoi elle s'est fracturée son poignet droit. Lors de l'examen clinique elle vous parle de sa famille et de leurs ATCD de fracture, de ses polyarthralgies qui ne passent pas sous traitement. Vous retrouvez une patiente maigre avec un goitre ainsi qu'un carnet de santé qui vous fait noté une perte de 7cm de taille et un poids nettement diminué : QUEL FDR CONNU POUR L'OSTEOPOROSE NE RETROUVEZ VOUS PAS ICI ?

- a. Hyperparathyroïdie
- b. Hyperthyroïdie
- c. Corticothérapie
- d. ATCD personnel ou familiale de fracture à risque
- e. Malabsorption / Denutrition



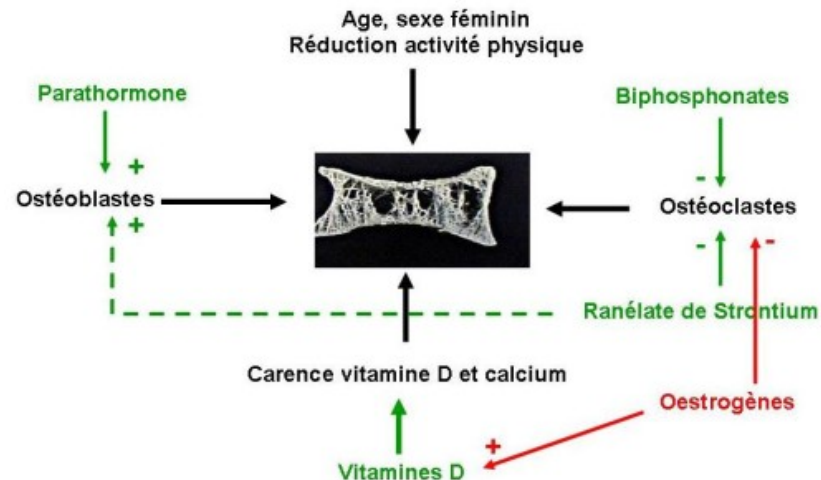
0. GENERALITEES : Ostéoporose

0.1 Madame H. se présente à votre consultation de rhumatologie, elle veut comprendre pourquoi elle s'est **fracturée son poignet droit**. Lors de l'examen clinique elle vous parle de sa famille et de leurs **ATCD de fracture**, de ses polyarthralgies qui ne passent pas sous **traitement**. Vous retrouvez une patiente **maigre** avec un **goitre** ainsi qu'un carnet de santé qui vous fait noté une **perte de 7cm** de taille et un poids nettement diminué : **QUEL FDR CONNU POUR L'OSTEOPOROSE NE RETROUVEZ VOUS PAS ICI ? (a. Hyperpara)**

REP A

Facteur de risques d'ostéoporose :

- Carence oestrogénique
- Hypogonadisme
- BMI<18Kg/m²
- Corticostéroïde
- Apport calcique faible (<400mg/j)
- Mobilité restreinte
- Maladie inflammatoire (métabolisme osseux)
- Tabagisme, alcoolisme
- Etiologies endocriniennes (2ndr) : hypogonadisme, hypercorticisme, hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie.



0. GENERALITEES : Ostéoporose

0.2 Madame H. revient vous voir, heureuse du temps que vous lui avez accordé. Elle vous présente son bilan d'ostéoporose : *DMO (T-score) -3.2 ET en dessous de la moyenne des jeunes adultes.* COMMENT INTERPRETEZ VOUS SON BILAN.

- a. Résultats non interprétables car biaisés par la moyenne des jeunes adultes
- b. Normal
- c. Ostéopénie
- d. Ostéoporose
- e. Ostéoporose sévère



0. GENERALITEES : Ostéoporose

0.2 Madame H. revient vous voir, heureuse du temps que vous lui avez accordé. Elle vous présente son bilan d'ostéoporose : **DMO = -3.2 ET, en dessous de la moyenne des jeunes adultes.** COMMENT INTERPRETEZ VOUS SON BILAN. **(e. Ostéoporose sévère)**

Densité minérale osseuse (DMO) en Ecart-type (ET) de la moyenne des jeunes adultes

- ~~a. Résultats non interprétables car biaisés par la moyenne des jeunes adultes~~
- b. Normal** : moins -1 ET
- c. Ostéopénie** : entre -1 et -2.5 ET
- d. Ostéoporose** : moins de -2.5 ET
- e. Ostéoporose sévère** : moins de -2.5 ET + fracture ostéoporotique



0. GENERALITEES : Complications en orthopédie

0.3 Monsieur T. est un jeune patient d'origine africaine que vous prenez en charge dans le cadre d'un AVP moto avec fracture transverse du fémur gauche. Vous optez pour une enclouage centromédulaire, réalisé avec succès. Le lendemain vous êtes appelé par l'infirmière pour tachycardie et tachypnée, hémoptysie, obnubilation et pétéchies au creux axillaire. QUEL DIAGNOSTIC EVOQUEZ –VOUS ?

- a. Ischémie aiguë de membre sur garrot
- b. Syndrome des loges à répercussion systémique
- c. Emboles graisseux
- d. Compression du nerf vague (Nerf X ou nerf pneumogastrique) au voisinage
- e. Thrombose veineuse profonde



0. GENERALITEES : Complications en orthopédie

0.3 Monsieur T. est un jeune patient d'origine **africaine** que vous prenez en charge dans le cadre d'un AVP moto avec fracture transverse du **fémur gauche**. Vous optez pour une **enclouage** centromédulaire, réalisé avec succès. Le **lendemain** vous êtes appelé par l'infirmière pour **tachycardie et tachypnée, hémoptysie, obnubilation et pétéchies au creux axillaire**. QUEL DIAGNOSTIC EVOQUEZ –VOUS ? (**c. Emboles graisseux**)

Syndrome d'embolie graisseuse :

- 3% des fractures isolées aux membres inférieures
- Particules graisseuses systémiques -> Activation lipases -> libération d'acides gras libres
- AGL : vasculite, perméabilité capillaire, obstruction mécanique
- Triade : SDRA + Trouble neurologique + Pétéchies

TTT :

- Prévention
- Volémie
- Stress (analgésie)
- Corticothérapie
- CEC ECMO si sévère

-Albumine ?

-ATTENTION : héparine très discutée. Peut favoriser le phénomène de la cascade



0. GENERALITEES : Gestion de la cicatrisation

0.4 Monsieur D. est un policier professionnel. Ce dernier est adressé à votre consultation de chirurgie plastique devant la mauvaise évolution d'une plaie. La plaie est superficielle, sur le visage et évolue depuis plus de 15 jours. QUEL ELEMENTS N'INDUIT HABITUELLEMENT PAS DE RETARD DE CICATRISATION ?

- a. Trouble de la coagulation
- b. Diabète
- c. Infection
- d. Hypercholestérolémie
- e. Déficit immunitaire



0. GENERALITEES : Gestion de la cicatrisation

0.4 Monsieur D. est un policier professionnel. Ce dernier est adressé à votre consultation de chirurgie plastique devant la **mauvaise évolution d'une plaie**. La plaie est superficielle, sur le **visage** et évolue **depuis plus de 15 jours**. QUEL ELEMENTS N'INDUIT HABITUELLEMENT **PAS** DE RETARD DE CICATRISATION ? (d. **Hypercholestérolémie**)

Retard de consolidation : > J15

- Diabète (leucocytes, hypoxémie, appuis, infections)
- Infection (dégradation matrice- extra cellulaire)
- Malnutrition (apports)
- Insuffisance veineuse ou artériosclérose
- Déficit immunitaire
- Trouble de la coagulation
- Corticothérapie



1. PEDIATRIE : Boiterie chez l'enfant

1.1 Antoine est un adolescent de 13 ans, bien portant, qui vous consulte dans le cadre de la médecine scolaire. Vous remarquez qu'il entre en consultation avec une boiterie permanente en rotation externe à gauche. Les paramètres sont bon, vous remarquez cependant une vive douleur à la rotation interne. Vous obtenez finalement ces radiographies. QUEL DIAGNOSTIC RETENEZ VOUS ?

- a. Exostose ostéogénique avec conflit de hanche
- b. Scoliose sévère
- c. Epiphysiolyse de hanche
- d. Ostéochondrite disséquante
- e. Fracture épiphysio-diaphysaire fémur



1. PEDIATRIE : Boiterie chez l'enfant

1.1 **Antoine** est un adolescent de **13 ans**, bien portant, qui vous consulte dans le cadre de la médecine scolaire. Vous remarquez qu'il entre en consultation avec une **boiterie permanente** en **rotation externe** à gauche. Les **paramètres sont bon**, vous remarquez cependant une **vive douleur à la rotation interne**. Vous obtenez finalement ces radiographies. QUEL DIAGNOSTIC RETENEZ VOUS ? (**c. Epiphysiolyse de hanche**)

Tout âge : néoplasie et infections hématogènes (à exclure)

Jusqu' à 3 ans : fracture metaphysaire, infection hématogène (souvent virale), cause neurologique (par exemple syndromes particuliers)

3 à 10 ans

- **Rhume de hanche** : hiver, brutale, apyrétique, éliminer infection, Rx normal, AINS +++
- **Ostéochondrite primitive de hanche** : nécrose ischémique de l'épiphyse fémorale, souvent chez les garçons Garçon ++

10 ans et plus

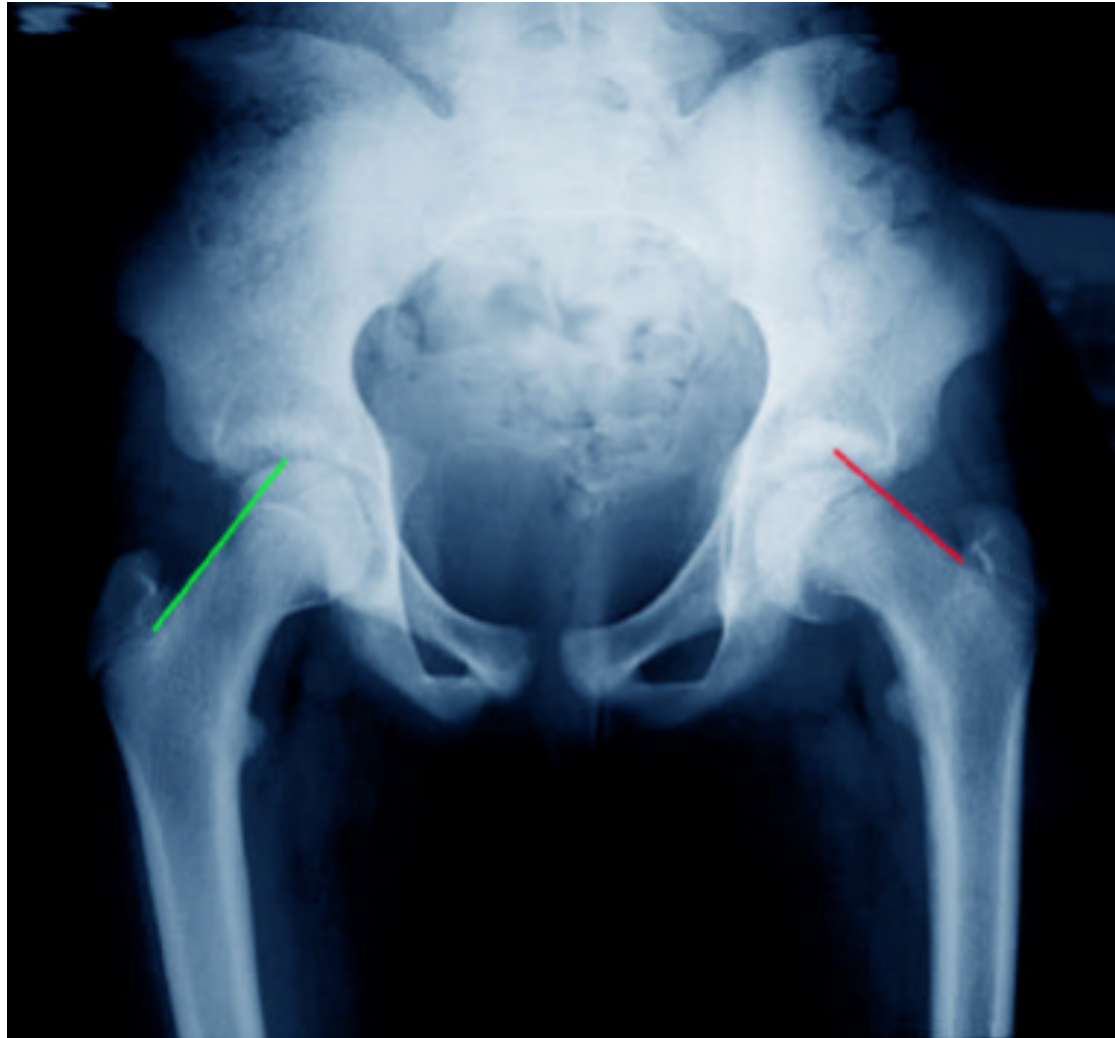
- **Ostéochondrite disséquante** ^{isolée} : condyles fémoraux, astragale, têtes fémorales
- **Epiphysiolyse de hanche** : Patient prépubert bien portant

RX: - Bascule en dedans avec Σ susmentionnés

- Glissement postérieure
- Lignes de Klein



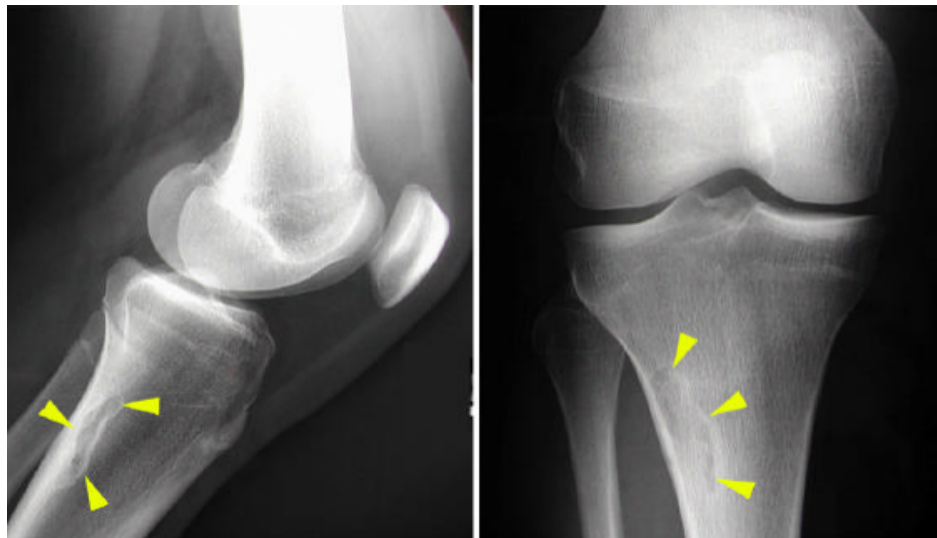
Lignes de Klein



1. PEDIATRIE : Néoplasie chez l'enfant

1.1 Magalie est une jeune fille de 9 ans. Sa mère vous consulte devant des radiographies osseuses inquiétantes faites lors d'un bilan inhabituel d'âge osseux. QUELLE PORPOSITION EST JUSTE SUR LA BASE DE LA RADIOGRAPHIE ? (cf photo question modifiée)

- a. Lésion bénigne car les limites sont nettes et la corticale est préservée
- b. Lésion bénigne car il y a un liseré de condensation périphérique avec des érosions
- c. Lésion bénigne car il y a une réaction périoste avec une petite taille
- d. Lésion maligne car les limites sont floues avec une érosion corticales
- e. Lésion maligne car réaction périoste et une condensation périphérique



1. PEDIATRIE : Néoplasie chez l'enfant

1.1 Magalie est une jeune fille de 9 ans. Sa mère vous consulte devant des radiographies osseuses inquiétantes faites lors d'un bilan inhabituel d'âge osseux. QUELLE PORPOSITION EST JUSTE SUR LA BASE DE LA RADIOGRAPHIE ? (a. lésion bénigne) REP A

*Os : 5-10% des tumeurs chez l'enfant dont $\frac{3}{4}$ bénignes (ostéome ostéoïde +++)
Ostéosarcome (genou) et tumeur d'Ewing (MI, bassin) : 90% des tumeurs malignes.*

LESION BENIGNE : ttt AINS

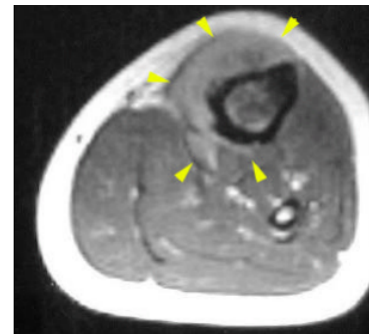
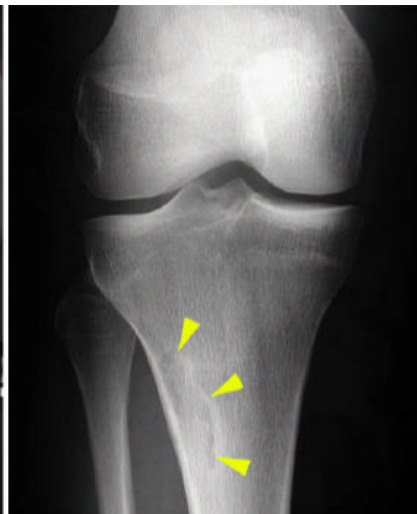
- Petite taille
- Limites nettes
- Condensation périphérique
- Corticale préservées
- Absence d'atteinte des parties molles
- Métaphysaire +++**

LESION MALIGNE :

- Grande taille (>6cm)
- Limites floues
- Absence de condensation périph
- Erosion corticale
- Invasion des parties molles
- Réaction périostée



Feu d'herbes



Eperon de Codman



2. RACHIS

2.1 Un jeune homme de 17 ans, en apprentissage chez un maçon est adressé à votre consultation du rachis. Il se plaint de douleur dorsale en fin de journée et d'un aspect inesthétique de sa silhouette. Ses paramètres cliniques sont dans la norme. AU VU DE LA PHOTO ET DE SES RADIOGRAPHIES, QUEL DIAGNOSTIC DOIT- ON EVOQUER ?

- a. Mal de Pott
- b. Maladie de Scheuermann
- c. Spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew)
- d. Cyphose post traumatique
- e. Spina Bifida (Myelomeningocèle)



2. RACHIS

2.1 Un jeune **homme de 17 ans**, en apprentissage chez un maçon est adressé à votre consultation du rachis. Il se plaint de **douleur dorsale en fin de journée** et d'un aspect **inesthétique** de sa silhouette. Ses paramètres cliniques sont **dans la norme**. AU VU DE LA PHOTO ET DE SES RADIOGRAPHIES, QUEL DIAGNOSTIC DOIT- ON EVOQUER ? (b.

Maladie de Scheuermann)

Cyphose anormale : cyphose thoracique $> 50^\circ$

CYPHOSE ENFANT, ADOLESCENT

-m. Scheuermann : *

- + fréquent, dorsale, garçon
- hyperlordose de compensation
- plateaux irréguliers
- cunéiformisation > 3 vertèbres
- hernie intra spongieuses de Schmorl (hyperpression)

- Neurologique : hypotonie, myopathie de Duchenne

svt autre cause

CYPHOSE DE L'ADULTE

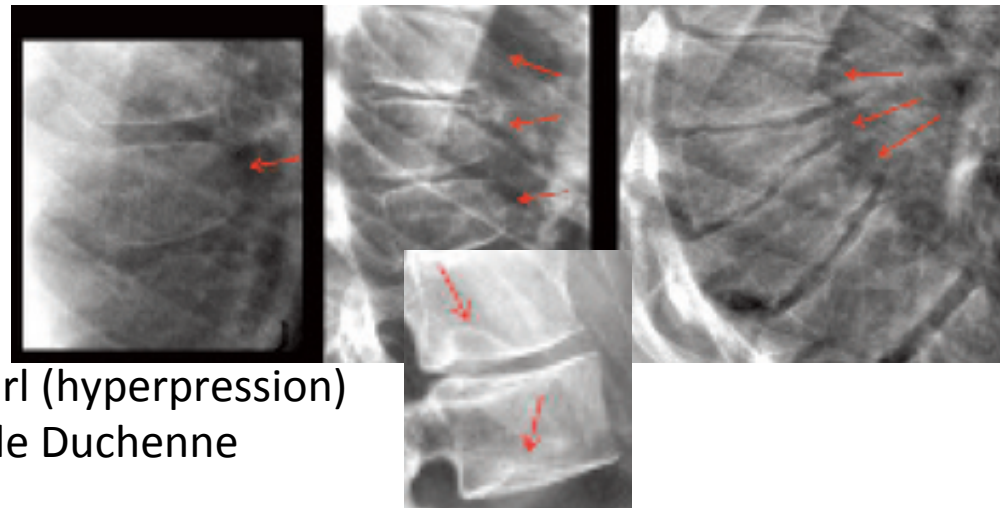
-**Mal de Pott** : spondylodiscite à *Mycobacterium tuberculosis* (bacille de Koch), thoracique

-**SAK (m. Bechterew)** : HLA-B27, sacro-iliite, jonction cervico-thoracique

-**Insuffisance ou post- fracturaire** : agé, ostéoporose, micro/macro traumatisme

-**Post opératoire** : laminectomie

*dystrophie rachidienne de croissance. Garçon +++



2. RACHIS

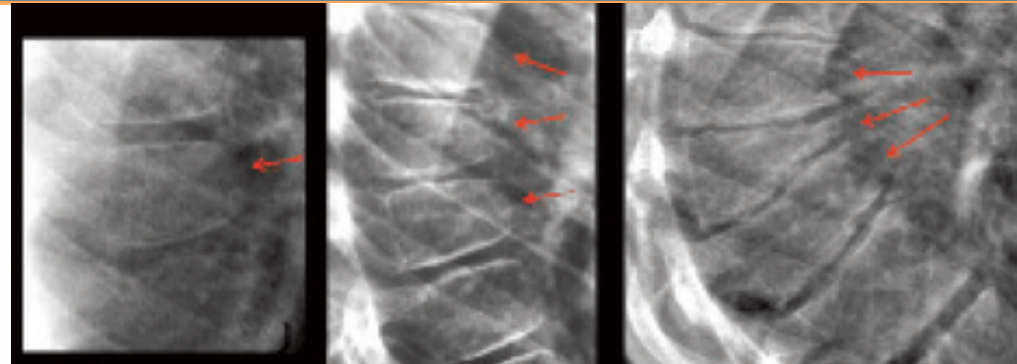
CYPHOSE PATHOLOGIQUE :

- Cyphose thoracique $> 50^\circ$
- Lordose lombaire $< 20^\circ$

CYPHOSE ENFANT, ADOLESCENT

- **m. Scheuermann** : *dystrophie rachidienne de croissance (ant. Vertèbres)*

- + fréquent, dorsale, garçon
- hyperlordose de compensation
- plateaux irréguliers
- cunéiformisation > 3 vertèbres, $> 5^\circ$
- hernie intra spongieuses de Schmorl
- Neurologique : hypertonie



CYPHOSE DE L'ADULTE

- **Mal de Pott** : spondylodiscite à *Mycobacterium tuberculosis* (bacille de Koch), thoracique
- **SAK (m. Bechterew)** : HLA-B27, sacro-iliite, jonction cervico-thoracique
- **Insuffisance ou post- fracturaire** : agé, ostéoporose, micro/macro traumatisme
- **Post opératoire** : laminectomie

3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

OSSEUX

- Fracture du radius distal
- Fracture du scaphoïde
- Fracture des os de l'avant bras

TISSU MOU

- Phlegmon des fléchisseurs
- Lésion du ligament scapholunaire



3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

3.1 Patient de 85 ans, se présente aux urgences pour douleurs et tuméfaction du doigt après une morsure par un chat à l'EMS : QUEL DIAGNOSTIC EST LE PLUS PROBABLE ?

- a. Ostéomyélite aiguë à *Streptococcus agalactiae*
- b. Arthrite septique à *Pasteurella* spp.
- c. Phlegmon des fléchisseurs à *Pasteurella multocida*
- d. Arthrite septique à *Clostridium tetani*
- e. Phlegmon des extenseurs à *Pasteurella* spp.



3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

3.1 Patient de 85 ans, se présente aux urgences pour douleurs et tuméfaction du doigt après une morsure par un chat à l'EMS : Phlegmon des fléchisseurs à Pasteurella Multocida

Classification :

- Stade I : sérite, exsudative avec simple distension de la gaine
- Stade II : liquide trouble ou purulent avec synoviale pathologique mais tendons intacts
- Stade III : nécrose +/- étendue des tendons.

Signes cliniques

- Oedème digital ou digito-palmaire
- Douleur sur le trajet de la gaine des tendons fléchisseurs
- Attitude en crochet flexum antalgique
- Douleur à l'extension passive
- Douleur au cul de sac de la gaine des fléchisseurs du doigt intéressé (douleur « paradoxale »).



Pasteurella multocida : bacille gram négatif (chat) Morsure / griffure !! ≠ maladie des griffes de chat

3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

Morsure de chat :

- Pasteurella multocida (BGN)
- Morsure, griffure
- Amoxicilline/doxycycline ou fluoroquinolone si allergies pénicillines (10-14 j)

SIGNES CLINIQUES DU PHLEGMON DES FLECHISSEURS :

- Œdème digital ou digito-palmaire
- Douleur sur le trajet de la gaine des tendons fléchisseurs
- Attitude en crochet
- Douleur à l'extension passive
- Douleur au cul de sac de la gaine des fléchisseurs du doigt intéressé (douleur « paradoxale »)

SIGNES CLINIQUES D'UNE ARTHRITE SEPTIQUE : Inflammation du cartilage

- Douleur à la mobilisation (impotence fonctionnelle)
- Mise en charge axiale douloureuse (inflammation cartilage, pression purulente)
- Tuméfaction des récessus

Inflammation locale



3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

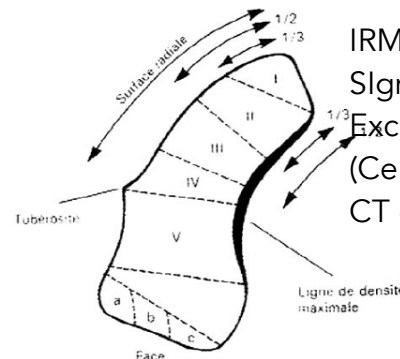
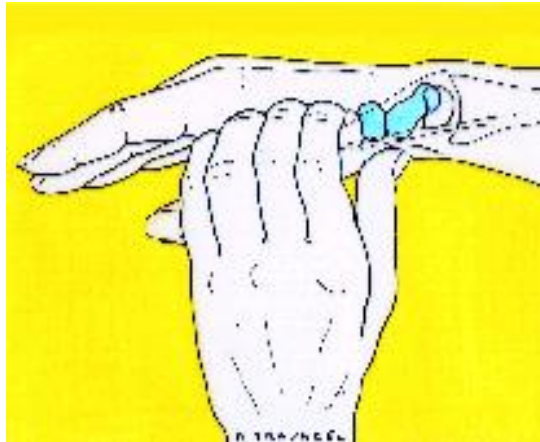
3.2 Patiente de 35 ans, chute en vélo avec douleur du poignet gauche, sans déformation. Pression de la tabatière anatomique douloureuse avec piston du pouce algique. La radiographie est sans particularité. QUEL DIAGNOSTIC EST LE PLUS PROBABLE ?

- a. Fracture du scaphoïde à exclure par une IRM
- b. Fracture du trapèze à exclure au CT scan
- c. Fracture du trapézoïde à exclure sur les incidences de Shrek
- d. Fracture du trapézoïde à exclure au CT
- e. Fracture du radius A2 selon l'AO à exclure par une Rx 3/4



3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

3.2 Patiente de **35 ans**, chute en **vélo** avec douleur du poignet gauche, sans déformation. Pression de la **tabatière anatomique** douloureuse, avec piston du pouce algique. La radiographie est sans particularité. **Fracture du scaphoïde**



IRM !! Le + sensible
Signes indirectes de la #
Excitation molécules H₂O → inflammation?? directe
(Ce jour)
CT est ~Rx (aspect morpho)

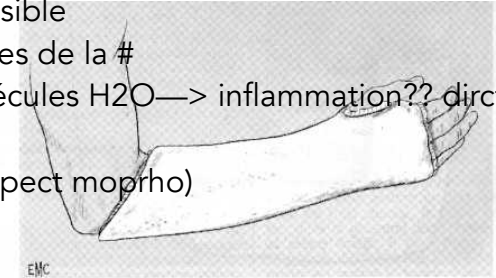


Figure n° 2. Plâtre antébrachio-palmar ou manchette plâtrée.

Figure extraite de : Kampt I, Pidhorz L. Appareils de contention externe. ESME sas, tous droits réservés. Techniques chirurgicales orthopédie-traumatologie, Paris, 44-007, 1997.

3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

Stratégie clinique :

- Cinétique et mécanisme
- Tabatière anatomique
- Tubercule du scaphoïde (antérieur)
- Piston axiale du pouce

Stratégie radiologique :

- **Rx** : débrouillage, faux négatifs +++
- **Incidence spécifique du scaphoïde** : Shrek
- **CT Scan** : anatomie du scaphoïde fracturé. Ne permet pas d'EXCLURE (nombreux faux négatifs) Apprécier la #, pré OP
- **IRM** : œdème, signe indirect très sensible en aigue
Exclure



3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

3.3 Patiente de 75 ans, qui chûte dans les escaliers est se présente aux urgences avec déformation de son poignet droit. QUEL DIAGNOSTIC EST LE PLUS COURANT ?

- a. Fracture du scaphoïde
- b. Fracture du radius distal
- c. Fracture de la styloïde ulnaire isolée
- d. Fracture de l'ulna métaphysaire isolée
- e. Déformation plastique sur os ostéoporotique



3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

Âgé : Radius distal, TFCC & hanche !!

3.3 Patiente de **75 ans**, qui chute dans les escaliers est se présente aux urgences avec **déformation de son poignet droit**. **Fracture du radius distal**

FX DU RADIUS DISTAL :

Fréquent +++ avec le fémur proximal
Déplacement épiphysaire **dorsale** > palmaire

Rechercher complications associées

- Fracture ouverte
- Syndrome du **tunnel carpien** (lésion neuro?)

N médian

Hématome comprime

Réduire + immobiliser (AB = antébrachial, BAB)

Opérer = critères d'instabilités ?

selon état

- Déplacement
- Comminution
- Age (réduction tient moins bien si âgé)

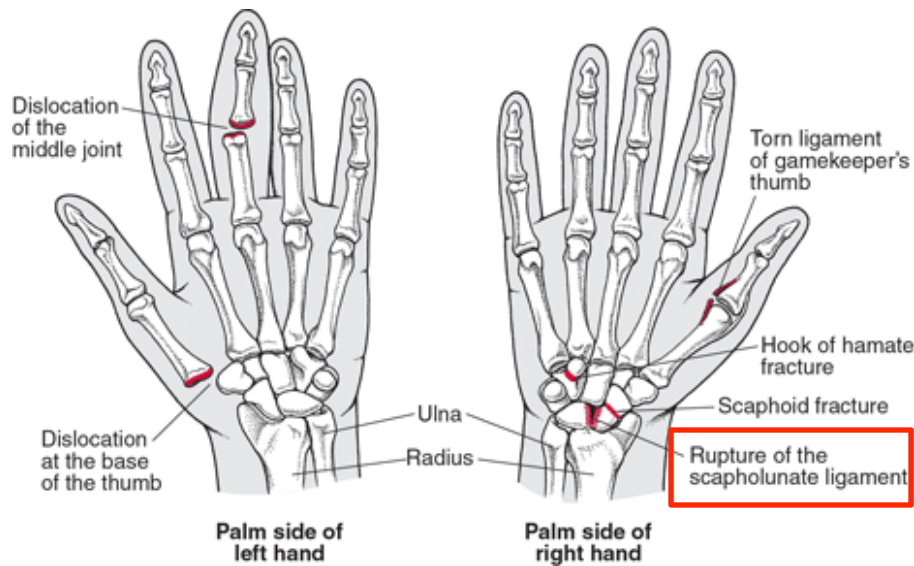


Styloïde ulnaire : ligament TFCC (stabilise cubitus et radius) !! toujours evaluer



3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

Fracture du radius distal chez le **jeune** - > haute cinétique -> lésions associées :
PENSER A LA LESION DU LIGAMENT SCAPHOLUNAIRE



- Examen clinique : test de Watson
- Examen paraclinique des lésions ligamentaire : Arthro-IRM
- Risque : instabilité du carpe = arthrose

Lésion TFCC chez patient jeune ou âgé

Conséquence a long terme !! Arthrose

3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

3.4 Patient de 25 ans se présente aux urgences pour une chute en BMX avec tuméfaction de l'avant bras et douleurs palpatoires diffuses. L'avant bras est déformé et le patient hurle de douleurs. QUEL URGENCE NE DOIT- ON PAS MANQUER AU VU DES RADIOGRAPHIES ?

- a. Fracture du poignet associée
- b. Lésion du nerf radial
- c. Fracture ouverte Gustillo 3c
- d. Syndrome des loges
- e. Luxation de l'épaule



3. MEMBRE SUPERIEUR : poignet, main, AB

Trauma sévère. Av bras / jambe !!!

—> synd loges. Dx Clinique

1.4 Patient de 25 ans se présente aux urgences pour une chute en BMX avec tuméfaction de l'avant bras et douleurs palpatoires diffuses. L'avant bras est déformé et le patient hurle de douleurs. Syndrome de loges de l'avant bras 2 os ! Risque ++ hémorragie(oedeme) (Av bras et jambe)

Diagnostic clinique

- Douleurs importantes malgré les morphiniques +++
- Extension douloureuse des doigts
- Attitude en flexion des doigts
- Loges tuméfiées
- Dysesthésie (**tard**)
- Trouble trophique (**tard**)

Sd de Volkmann : syndrome des loges dépassé (nécrose des muscles) *trop tard

Touche aussi la jambe : fracture tibio-fibulaire

Fasciotomie des loges en urgences +/- OS

Toujours y penser !

- avant-bras ou jambe

- 2 atteintes du même segment (luxation, fracture)



3. MEMBRE SUPERIEUR : coude, humérus, épaule

OSSEUX

- Luxation du coude
- Luxation de l'épaule
- Fracture de l'humérus

TISSU MOU

- Lésion neurologique
- Lésion de la coiffe des rotateurs



3. MEMBRE SUPERIEUR : coude, humérus, épaule

3.1 Patiente de 33 ans, chute en roller avec poignet en extension. Déformation du coude et paresthésie du 5^{ème} doigt et de la moitié du 4^{ème}. A QUELLE COMPLICATION NEUROLOGIQUE CE TABLEAU VOUS FAIT PENSER ?

- a. Luxation du coude et compression du nerf median
- b. Fracture de la palette humérale et compression du nerf ulnaire
- c. Luxation de la tête radiale et compression du nerf median
- d. Fracture de l'olécrane et compression du nerf radial
- e. Fracture-luxation du coude et compression du nerf radial



3. MEMBRE SUPERIEUR : coude, humerus, épaule

3.1 Patiente de 33 ans, chute en roller avec **poignet en extension. Déformation du coude et paresthésie du 5^{ème} doigt et de la moitié du 4^{ème}** : Fracture de la palette humérale et compression du nerf ulnaire



Bequilles longtemps : main tombante .-> N. radial!
Trauma coude : examen neuro vasc!!

3. MEMBRE SUPERIEUR : coude, humerus, épaule

Territoires d'intérêts :

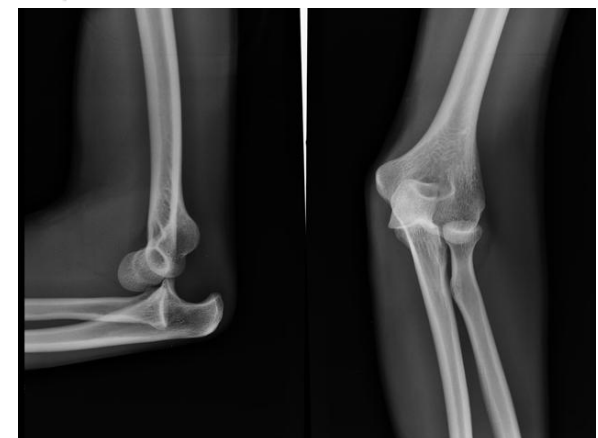
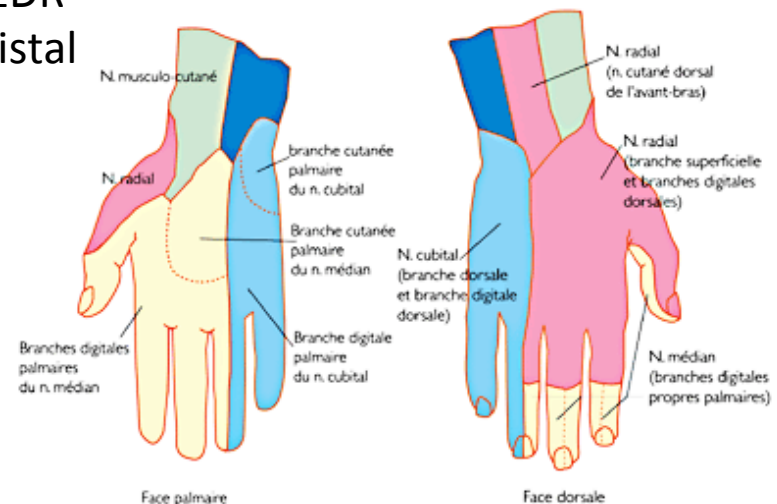
- Nerf ulnaire : fracture palettelle humérale
- Nerf médian : luxation postero-latérale du coude, EDR
- Nerf radial : fracture de l'humerus au 1/3 moyen-distal

Luxation du coude :

- Réduction en urgence
- Test de la stabilité du coude
- Bilan clinique (vasculaire > neurologique)
- Délai = sd des loges

Etiologie neurologique :

- Hématome compressif (fracture)
- Section au foyer de fracture (rare)
- Etirement (luxation)
- Compression locale (cannes axillaires)



3. MEMBRE SUPERIEUR : coude, humérus, épaule

3.2 Patient de 45 ans, qui chute en vélo avec réception sur le membre supérieure gauche. Il arrive aux urgences avec une main tombante et un hématome au 1/3 distal du bras : QUELLE URGENCE EVOQUEZ VOUS ?

- a. Fracture de l'humérus et lésion du nerf radial
- b. Luxation de l'épaule et compression du nerf axillaire
- c. Fracture de l'épicondyle et désinsertion ligamentaire
- d. Luxation vertébrale et déficit du tronc inferieure (plexus brachial)
- e. Instabilité du nerf ulnaire post-fracturaire



3. MEMBRE SUPERIEUR : coude, humérus, épaule

!!!++++

3.2 Patient de 45 ans, qui chute en vélo et arrive aux urgences avec une **main tombante et un **hématome du bras** : Fracture de l'humérus et lésion du nerf radial**

N. radial

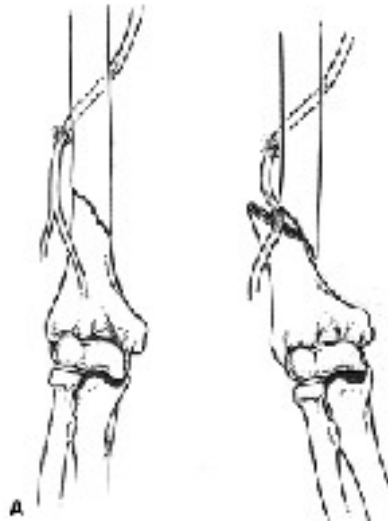
Fracture de l'humérus distal :

Passage du nerf radial

- 1/3 moyen-distal
- Loge post. -> ant.
- Incarcération +++ > section

Réduction +++

Chirurgie = révision nerveuse
si ncsr



Déficit d'extension du poignet et des doigts, hypoesthésie **dorsale** de la main (1,2,3 et hemi-4)

3. MEMBRE SUPERIEUR : coude, humérus, épaule

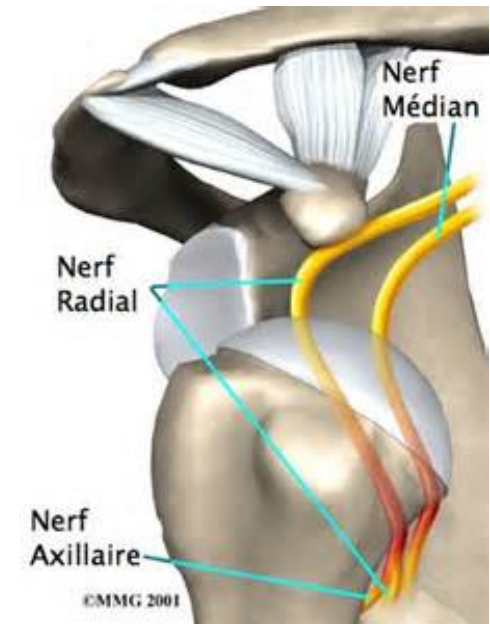
3.3 Patiente de 55 ans qui chute de sa hauteur avec réception sur l'épaule gauche. Impotence fonctionnelle totale. Admise aux urgences 3 jours plus tard : QUEL DIAGNOSTIC LE PLUS COURANT QUE L'ON NE DOIT-ON PAS MANQUER EN URGENCE ?

- a. Luxation acromio-claviculaire et lésion du tronc artériel brachio-céphalique gauche
- b. Luxation gléno-humérale et compression du nerf axillaire
- c. Fracture de la clavicule et lésion du nerf supraclaviculaire
- d. Rupture du muscle infra-épineux et instabilité chronique d'épaule
- e. Luxation gléno-humérale et compression de l'artère axillaire



3. MEMBRE SUPERIEUR : coude, humérus, épaule

3.3 Patiente de 55 ans qui chute de sa hauteur avec **réception sur l'épaule gauche**.
Impotence fonctionnelle totale. Admise aux urgences **3 jours** plus tard : **Luxation gléno-humérale** et compression du nerf axillaire



3. MEMBRE SUPERIEUR : coude, humérus, épaule

Luxation gléno-humérale :

- Traumatisme fréquent +++
- Antérieur (choc) > postérieur (épilepsie)

Hypoesthésie du moignon de l'épaule :

- Nerf circonflexe (axillaire)

Rare :

- compression de l'artère axillaire (poul radial)
- luxation postérieure

Risque de lésion de la coiffe des rotateurs !

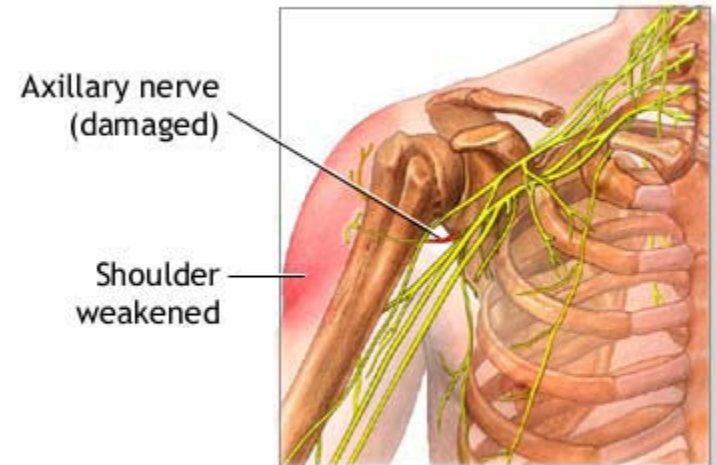
- Chez la personne âgée

Risque de récurrence !

- Chez le patient jeune

Réduction en urgence

- + examen clinique
- +/- examen radiologique (US, IRM ?)



3. MEMBRE SUPERIEUR : coude, humérus, épaule

3.4 Patiente de 36 ans, chute à moto il y a 15 jours. Impotence fonctionnelle partielle avec déficit en abduction et antépulsion : QUELLE EST L'ATTEINTE LA PLUS COURANTE A REDOUTER ?

- a. Rupture traumatique de la coiffe des rotateurs (tendon du sus-épineux)
- b. Rupture traumatique de la coiffe des rotateurs (tendon du sous-épineux)
- c. Rupture traumatique de la coiffe des rotateurs (tendon du sub-scapulaire)
- d. Rupture du tendon du muscle court biceps
- e. Fracture sous capitale de l'humérus



3. MEMBRE SUPERIEUR : coude, humérus, épaule

3.4 Patiente de **36 ans, chute à moto** il y a 15 jours. Impotence fonctionnelle partielle avec déficit **en abduction et antépulsion** : Rupture traumatique de la coiffe des rotateurs (tendon du sus-épineux)

La coiffe des rotateurs :

- RI : subscapulaire ; RE : infra-épineux, petit rond ; ABD : supra-épineux

Lésion traumatique

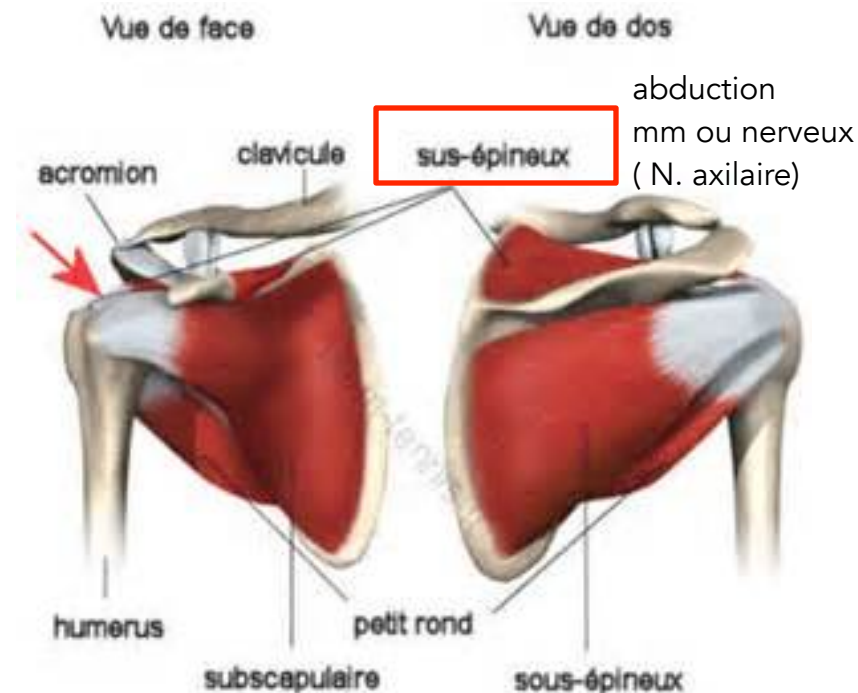
- Le patient jeune
- Haute cinétique
- Réparation chirurgicale !

Lésion dégénérative

- Le patient âgé
- Chronique
- Au cas par cas

Luxation G.H., traumatisme direct

- Lésion du tendon sus-épineux (fréquence)
- Bilan de la coiffe des rotateurs (US, IRM)



4. MEMBRE INFÉRIEUR : bassin, hanche, fémur

OSSEUX

- Fracture du bassin
- Fracture du fémur proximal

TISSU MOU

- Lésion neurologique
- Lésion vasculaire



4. MEMBRE INFÉRIEUR : bassin, hanche, fémur

4.1 Patient de 32 ans, AVP à moto, admis par le SMUR pour état hémodynamique instable malgré un remplissage conséquent : QUEL DIAGNOSTIC TRAUMATOLOGIQUE LE PLUS FREQUENT NE DEVEZ VOUS PAS RATER ?

- a. Rupture de l'artère épigastrique
- b. Fracture du sacrum et hypovolémie neurogène
- c. Fracture du bassin en « open book »
- d. Fracture fermée du fémur et choc hypovolémique/hémorragique
- e. Acidose métabolique sur ischémie aigue post luxation traumatique de genou



4. MEMBRE INFÉRIEUR : bassin, hanche, fémur

4.1 Patient de 32 ans, **AVP à moto**, admis par le SMUR pour **état hémodynamique instable** malgré un remplissage conséquent : **Fracture du bassin en « open book »**

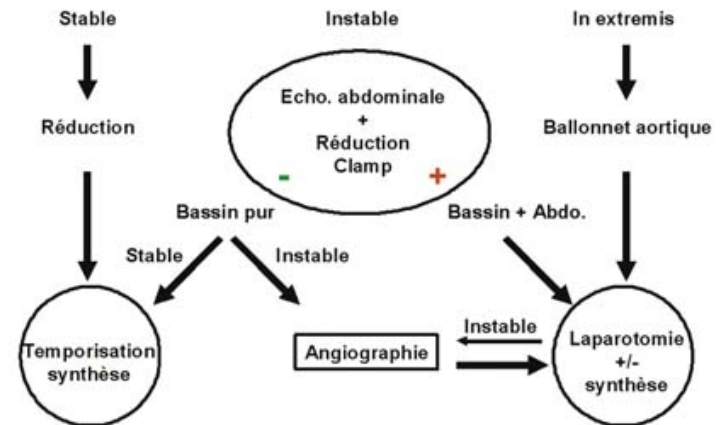
Fracture du bassin et instabilité HD :

- Grande urgence vitale du polytraumatisé
- Plexus veineux pré-sacré
- Ceinture de bassin < Pelvi-clamp
- Réduire le volume pelvien
- Seconde ligne : embolisation

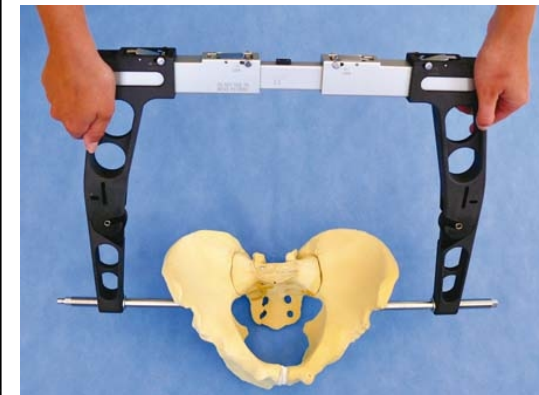
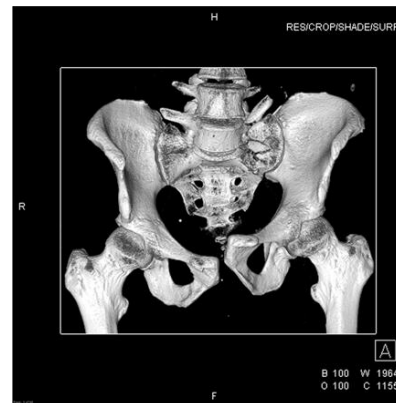
Association tragique : toujours vérifier/exclure

- Lésion splénique, hépatique, rénale (hile)
- Translocation bactérienne (rare)

Bassin + Syndrome hémorragique instable
à l'épreuve du remplissage - thorax et os longs vérifiés



Grenoble CHU Michallon - 2006



4. MEMBRE INFÉRIEUR : bassin, hanche, fémur

4.2 Patiente de 75 ans, qui chute de sa hauteur et réception sur le flanc droit. Impossibilité de se relever et membre inférieur en rotation externe, raccourcissement et adduction : QUEL DIAGNOSTIC LE PLUS PROBABLE DOIT- ON SUSPECTER ?

- a. Fracture du fémur proximal = col du fémur
- b. Fracture de la crête iliaque droite
- c. Fracture du rachis
- d. Fracture du sacrum
- e. Fracture du cotyle



4. MEMBRE INFÉRIEUR : bassin, hanche, fémur

4.2 Patiente de **75 ans**, qui chute de sa hauteur et réception sur le flanc droit.
Impossibilité de se relever et membre **inférieur en rotation externe, raccourcissement et adduction** : Fracture du fémur proximal



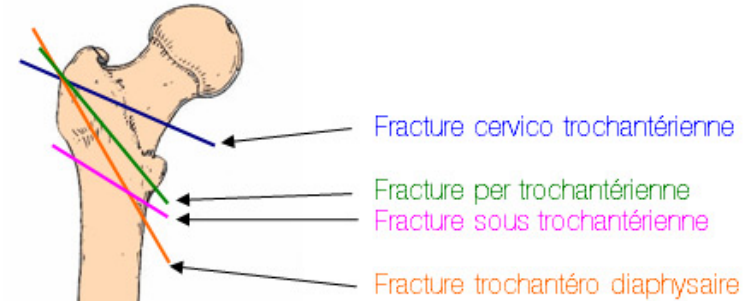
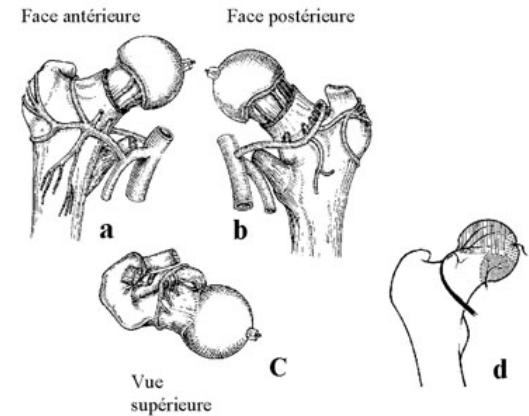
4. MEMBRE INFÉRIEUR : bassin, hanche, fémur

Personne âgée + chute :

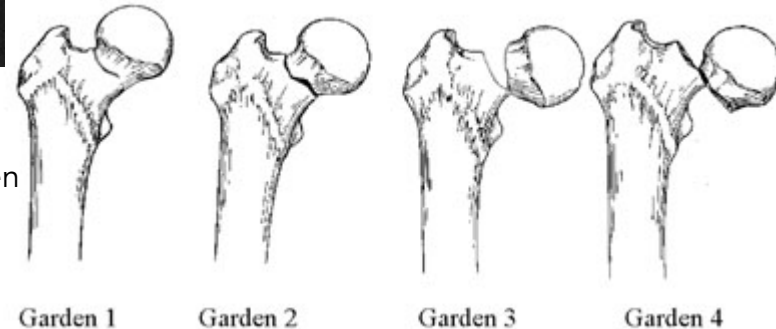
- Fracture EDR extrémité distale radius
- Fracture fémur proximal
- Syndrome post-chute : pas de mobilisation
- Déshydratation/désadaptation
- CAVE anticoag : lésion crâne, peau

Fracture fémur proximal :

- Incidence chez la personne âgée +++
- Vascularisation de la tête fémorale
 - Ostéonécrose
 - PTH, prothèse intermédiaire
- Ostéosynthèse : clou, DHS
- Comorbidités
- Rééducation à la marche
- Prise en charge multidisciplinaire



Garden



4. MEMBRE INFÉRIEUR : bassin, hanche, fémur

4.3 Patiente de 85 ans, qui chute de sa hauteur dans son EMS. Elle est connue pour une PTH gauche et se présente aux urgences pour impotence fonctionnelle totale de sa hanche gauche avec un membre raccourci en flexion ainsi qu'un status neurologique perturbé : QUEL DIAGNOSTIC EVOQUER ET QUELLE COMPLICATION EN ATTENDRE ?

- a. Fracture du fémur proximal et compression du nerf sciatique poplité externe (SPE)
- b. Fracture de la crête iliaque gauche et lésion du nerf cutané latéral de la cuisse
- c. Luxation de sa prothèse et compression du nerf sciatique
- d. Fracture-luxation du sacrum et compression de la queue de cheval
- e. Luxation de sa prothèse et compression du nerf tibial



C

4. MEMBRE INFÉRIEUR : bassin, hanche, fémur

4.3 Patiente de **85 ans**, qui chute de sa hauteur dans son EMS. Elle est connue pour une **PTH gauche** et se présente aux urgences pour **impotence fonctionnelle totale** de sa hanche gauche avec **un membre raccourci en flexion** : Luxation de sa prothèse et compression du nerf sciatique

Vois d'abord (ancien) dispose a une faiblesse post
Luxation si prothèse en post sup.
—> a réduire genou en flexion



4. MEMBRE INFÉRIEUR : bassin, hanche, fémur

PTH et ses faiblesses :

- Voie d'abord postérieure (courant)
 - Faiblesse postérieure
- Position de la cupule

Luxation sur prothèse :

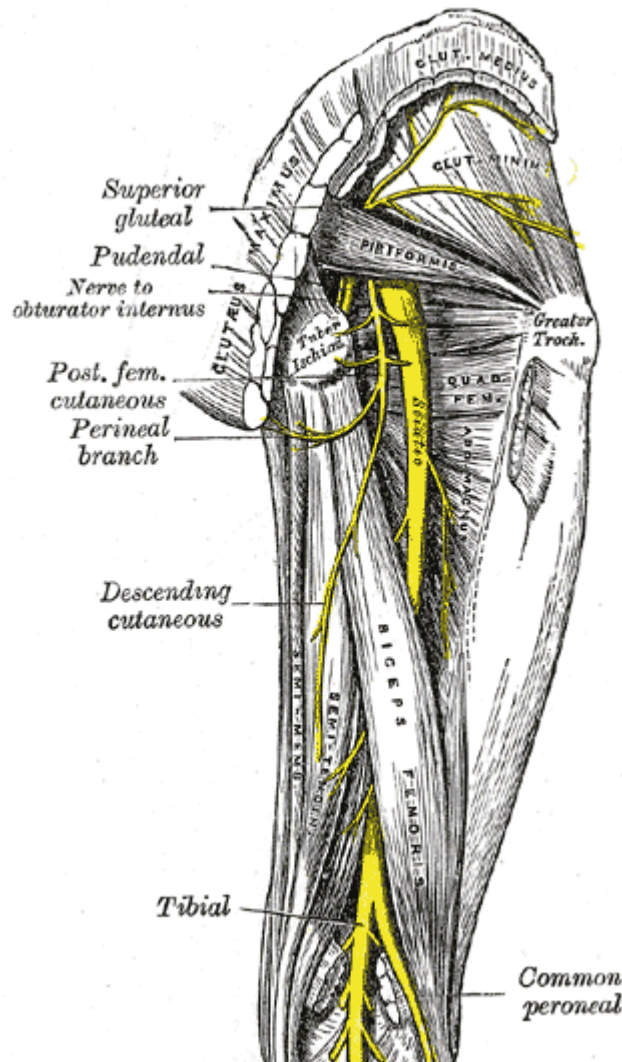
- Plus fréquent que hanche native
- Luxation postéro-supérieure

Réduction :

- Genou en flexion (relâche musculature et nerf)
- Bloquer la flexion du genou post-réduction

Risque :

- Incarcération du nerf sciatique



4. MEMBRE INFERIEUR : genou, tibia

OSSEUX

- Fracture de la rotule
- Fracture de la tête fibulaire

TISSU MOU

- Rupture des ligaments croisés

Texte



4. MEMBRE INFERIEUR : genou, tibia

4.1 Patiente de 18 ans, avec AVP en voiture, admis aux urgences pour un tuméfaction, épanchement intra-articulaire et douleur du genou droit après un choc direct avec le tableau de bord : QUELLE LESION RECHERCHEE ET QUEL ELEMENT ORIENTERA LE TRAITEMENT CONSERVATEUR ?

- a. Fracture de la tête fibulaire : instabilité de la syndesmose associée
- b. Rupture du LCA : pas de laxité au testing (mesure instrumentale)
- c. Fracture de la rotule : déficit d'extension
- d. Fracture de la diaphyse fémorale : syndrome des loges
- e. Rupture du quadriceps : bilan anatomique à l'IRM



4. MEMBRE INFÉRIEUR : genou, tibia

4.1 Patiente de 18 ans, avec **AVP en voiture**, admis aux urgences pour une tuméfaction, **épanchement intra-articulaire** et douleur du genou droit après **un choc direct** avec le tableau de bord : **Fracture de la rotule : déficit d'extension**



4. MEMBRE INFÉRIEUR : genou, tibia

Tableau de bord :

- Fracture de rotule
- Lésion du LCP
- Lésion à distance : fémur proximal / cotyle

Piège du bilan :

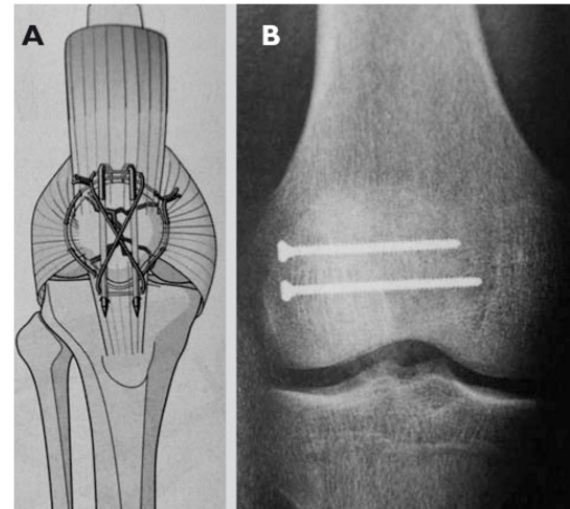
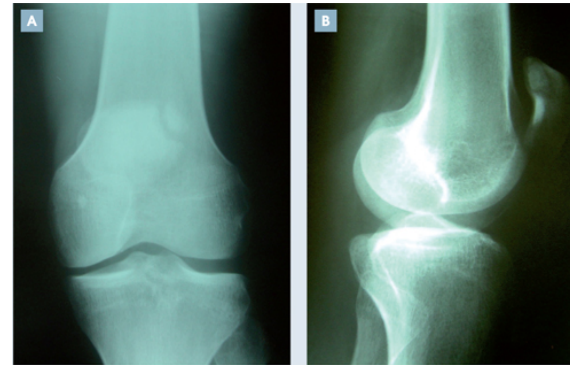
- Fracture : rotule bipartite
- Ligaments : hémarthrose aigue douloureuse

Traitement conservateur :

- Refend in-situ
- Testing de l'extension (appareil extenseur)
- Immobiliser en extension

Attention :

- Plaies +++ = fracture ouverte
- Immobilisation prolongées : amyotrophie quadriceps



4. MEMBRE INFERIEUR : genou, tibia

4.2 Patiente de 18 ans, avec AVP en voiture, admis aux urgences pour un tuméfaction et douleur du genou droit après un choc avec le tableau de bord : QUELLE LESION AUTRE QUE OSSEUSE DOIT ON RECHERCHER ?

- a. Lésion du LLI : testing en varus
- b. Lésion du LLE : testing en varus
- c. Lésion du LCA : manœuvre de Lachman
- d. Lésion du LCP : manœuvre en tiroir au postérieur
- e. Désinsertion du quadriceps : déficit d'extension active

4.2' Patient de 17 ans, admis en consultation du genou dans les suites d'un match de foot lors duquel il reçoit un tacle. Il présente un genou diffusément tuméfié avec mise en charge possible, mais difficulté surtout à la descente des escaliers : QUELLE LESION EST LA PLUS COURANTE DANS CE TYPE DE TRAUMATISME ?

Descente escaliers : Instabilité + marquée
Ligament croisés

- a. Lésion du LLI : testing en varus
 - b. Lésion du LLE : testing en varus
 - c. Lésion du LCA : manœuvre de Lachman
 - d. Lésion du LCP : manœuvre en tiroir au postérieur
 - e. Désinsertion du quadriceps : déficit d'extension active
- Il peut charger !!
LCA lésé mécanisme torsion (ski foot)
Tiroire ant et Lachmann



4. MEMBRE INFERIEUR : genou, tibia

4.2 Patiente de 18 ans, avec **AVP en voiture**, admis aux urgences pour un tuméfaction et douleur du **genou droit après un choc avec le tableau de bord** : quelle lésion autre que osseuse rechercher ? Lésion du LCP : manœuvre en tiroir au postérieur

4.2' : Lésion du LCA

LCP

- choc direct
- tableau de bord
- tiroir postérieur

LCA

- mécanisme en rotation
- foot, ski +++
- tiroir antérieur, test de Lachman

Chirurgie

Plastie/Greffe : LCA > LCP



<3 **Triade antéro-interne :**

LCA + LLI + ménisque interne
(test de Mc murray)



4. MEMBRE INFERIEUR : genou, tibia

4.3 Patient de 32 ans, chute lors de son footing, mécanisme rotation, douleur du genou droit avec radiographie ci-après. QUEL EST LE DIAGNOSTIC SUSPECTE, DE QUEL AUTRE EXAMEN AVEZ VOUS BESOIN ?

- a. Fracture du condyle fémorale déplacé en bas : CT scan
- b. Fracture occulte de la rotule : Rx axiale de rotule
- c. Rupture du LCA : IRM du genou
- d. Rupture de la syndesmosse : Rx de la cheville
- e. Fracture enfouissement du plateau tibial : Rx genou de face



4. MEMBRE INFÉRIEUR : genou, tibia

4.3 Patient de 32 ans, chute lors de son **foot, mécanisme en rotation, douleur du **genou droit** avec radiographie ci-après : Rupture de la syndesmose : Rx de la cheville**

Fracture de Maisonneuve : fracture en torsion !!

- Rotation externe forcée
- Fracture fibula proximal
- Rupture membrane interosseuse
- Lésion du LLI (ligament deltoïde)

Syndesmose :

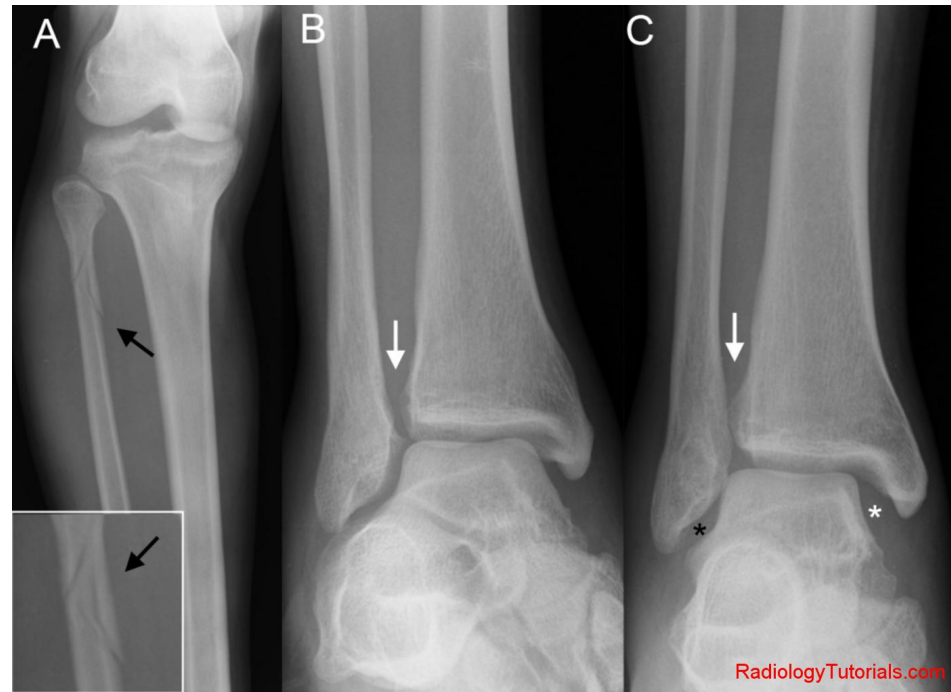
- Complexe de stabilisation T.F. distal
 - TFA + MOI + TFP
- Instabilité à rechercher (clinique, Rx)
- **Mortaise** incompétente
- Arthrose si pas de réduction
 - Articulation avec conflit —> arthrose

Fracture fibula proximal :

- Choc direct (transverse)
- Maisonneuve (spiroïde) : syndesmose ?

Nerf fibulaire commun puis fibulaire superficiel

- Releveur pied/orteil
- Examen # fibula / Genou
—> examiner le pied (releveur)



RadiologyTutorials.com



4. MEMBRE INFERIEUR : cheville, pied

OSSEUX

- Fracture de cheville
- Fracture du Lisfranc & Chopart

TISSU MOU

- Instabilité de la cheville



4. MEMBRE INFÉRIEUR : cheville, pied

4.1 Patiente de 22 ans, qui chute au football avec torsion de la cheville. Douleurs et impotence fonctionnelle total. Votre stagiaire vous dit que c'est une Weber C car elle ne peut pas poser le pied. QUELLE EXPLICATION LUI DONNEZ VOUS ?

- a. Ce n'est pas la classification de Weber mais de Schatzker
- b. C'est juste, car c'est un mécanisme en torsion, vous décidez de faire un IRM d'emblé pour bilanter la syndesmosse car c'est une structure ligamentaire
- c. On ne peut pas conclure sans radiographie
- d. C'est probablement des douleurs projetées, la cheville n'est pas en cause
- e. Un pied tombant peut être la conséquence vu le mécanisme



4. MEMBRE INFÉRIEUR : cheville, pied

4.1 Patiente de 22 ans, qui **chute au football avec torsion de la cheville**. Douleurs et **impotence fonctionnelle total**. Votre stagiaire vous dit que c'est une **Weber C** car elle ne peut pas poser le pied. On ne peut pas conclure sans radiographie

3 Malléoles : externe, interne ou postérieure

Mécanisme classification Weber :

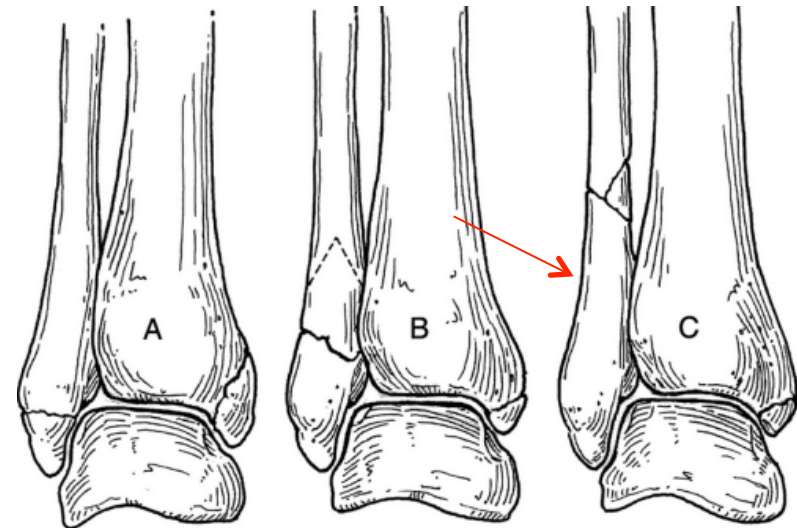
- A : inversion (varus + supination)
- B : éversion (valgus + pronation)
- C : éversion

Atteinte classification Weber : Interne

- A : MI malléole sous la syndesmose
- B : ME, +/- LLI, +/- S. Ant.
- C : ME au dessus de la syndesmose + LLI + MOI + S. Ant

Lésions associées :

- Luxation
- Nerf fibulaire (plus proximal)
- **Souffrance cutanée** : principal



possible instabilité par déchirure de la mortaise

4. MEMBRE INFERIEUR : cheville, pied

4.2 Patiente de 22 ans, qui chute au football avec torsion de la cheville. Douleurs et impotence fonctionnelle total. Après 6 mois, elle vous reconsulte car elle a des entorses à répétition. QUEL ELEMENT EST LE PLUS SOUVENT EN CAUSE ET COMMENT VALIDER VOTRE SUSPICION ?

- a. Une instabilité du Lisfranc : test en compression axial
- b. Une instabilité de l'articulation tibio-fibulaire proximale : test de cisaillement AP
- c. Le ligament talo-fibulaire antérieur : Drawer test
- d. Une instabilité du Chopard : test de cisaillement AP
- e. Une instabilité du ligament tibio-fibulaire antérieur : manœuvre de translation frontal



4. MEMBRE INFÉRIEUR : cheville, pied

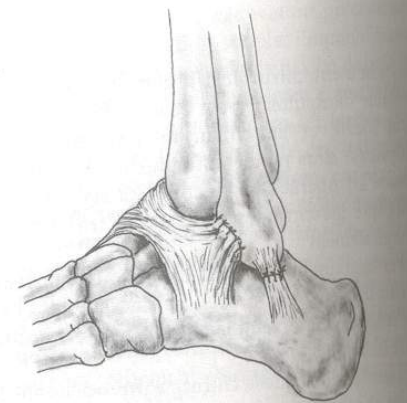
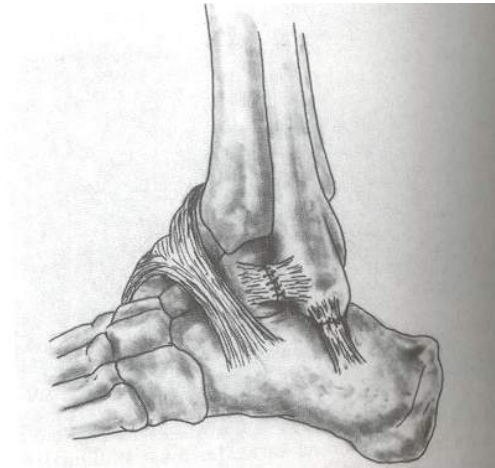
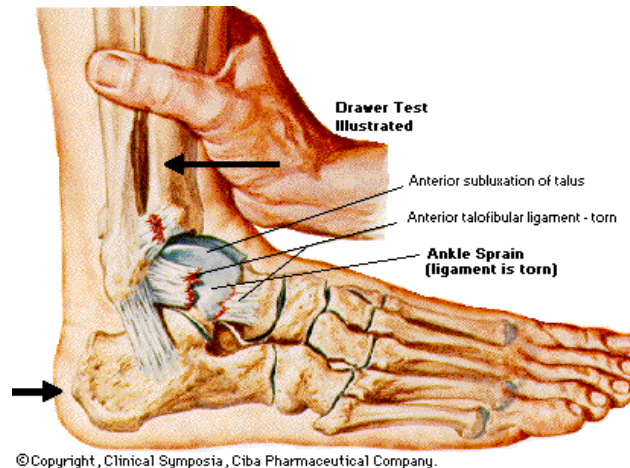
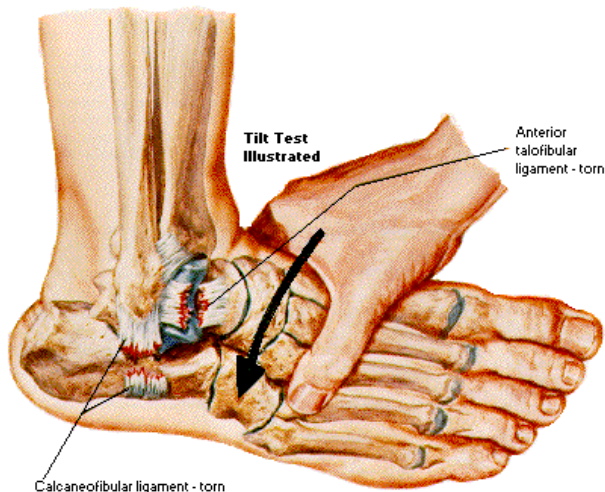
4.2 Patiente de 22 ans, qui chute au football avec **torsion de la cheville**. Douleurs et impotence fonctionnelle total. **Après 6 mois**, elle vous consulte car elle a **des entorses à répétition**.

Le ligament talo-fibulaire antérieur (Drawer test) + le ligament calcanéofibulaire associé (Tilt test).

Chirurgie :

Rétention ou capsulorrhaphie

Brostrom-Gould



4. MEMBRE INFÉRIEUR : cheville, pied

4.2 Patient de 42 ans chute à la réception d'un saut en parachute avec le pied en hyperflexion plantaire et arrive aux urgences pour des douleurs diffuses. QUEL EST LE PREMIER DIAGNOSTIC A EVOQUER ?

- a. Une luxation de l'articulation metatarso-phalangienne de l'Hallux (débord)
- b. Une rupture du ligament tibio-fibulaire antérieur
- c. Une atteinte du Lisfranc ou du Chopart
- d. Une rupture de l'artère dorsale du pied
- e. Fracture du calcanéum



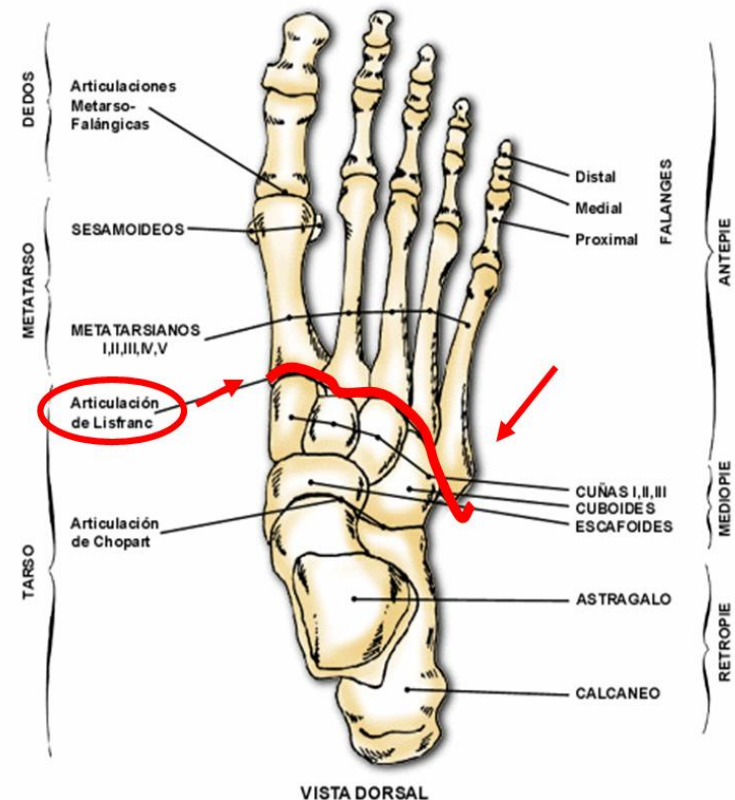
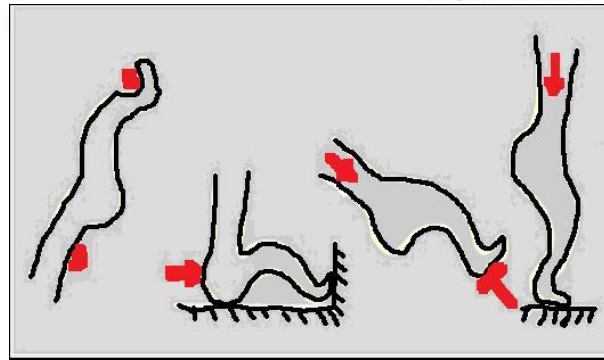
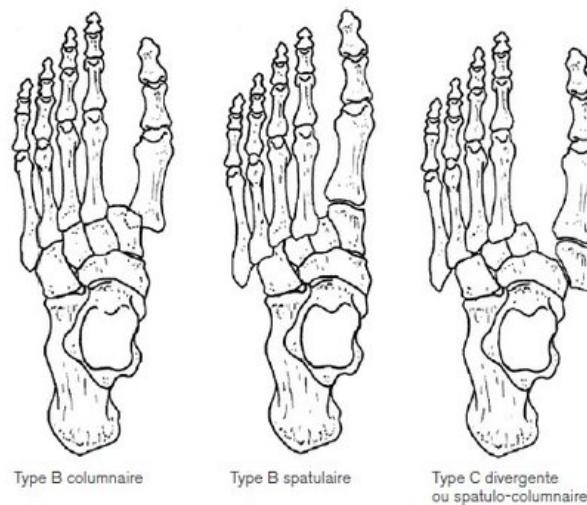
4. MEMBRE INFÉRIEUR : cheville, pied

4.2 Patient de 42 ans **chute à la réception** d'un saut en parachute avec **le pied en hyperflexion plantaire** et arrive aux urgences pour des douleurs diffuses. Une atteinte du **Lisfranc ou du Chopart**

2 sites de lésions principales

Lisfranc >> Chopart (proximal, de profile)

luxation



5. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m :

- Glasgow 8
- 130bpm, 60/35mmHg malgré le remplissage
- Collier cervical dans un matelas à dépression
- Tuméfaction des deux pieds

Quelle est la prise en charge initiale ?

- a. Remplissage > IOT > Rx > Ceinture pelvienne > Rx + bilan secondaire
- b. IOT > Remplissage > Ceinture pelvienne > Rx + bilan secondaire
- c. Ceinture pelvienne > Remplissage > IOT > Rx + bilan secondaire
- d. IOT > Rx + bilan secondaire > Ceinture pelvienne > Remplissage
- e. Remplissage > Ceinture pelvienne > IOT > Rx + bilan secondaire



6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

b. IOT > Remplissage > Ceinture pelvienne > Rx + bilan secondaire

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m :

- Glasgow 8 -> **Indication à une IOT**
- 130bpm, 60/35mmHg malgré le remplissage -> **Rechercher un point d'appel hémorragique !!**
- Collier cervical dans un matelas à dépression -> **Ceinture pelvienne !**
- Tuméfaction des deux pieds -> **Rx à la recherche d'une fracture des calcanéum ?**



6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m

*Après intubation, et pose d'un pelvic clamp, le patient se stabilise. La radiographie suivante vous parvient enfin :

Quelle autre fracture suspectée en priorité?

- a. Plateau tibial
- b. Fracture du fémur proximal
- c. Rachis
- d. Naviculaire
- e. Crête iliaque



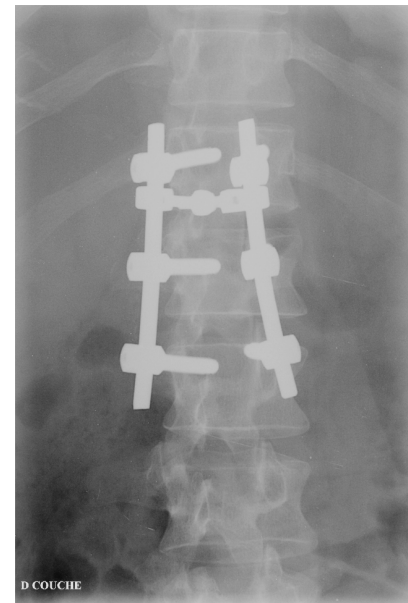
6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

c. Rachis

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m

Après intubation, et pose d'un pelvic clamp, le patient se stabilise. La radiographie suivante vous parvient enfin :

Quelle autre examen demander ? -> Rx +/- CT du rachis (fracture !!!) < bilan de la hanche (luxation ?)



6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m

Après intubation, et pose d'un pelvic clamp, le patient se stabilise.

*Le patient bénéficie d'un ostéosynthèse d'une fracture instable du rachis et de son calcanéum.

*Son état s'améliore et il sort enfin des soins intensifs avec une attelle jambière postérieure et une décharge totale pour 6 semaines.

Le jour de son retour dans l'unité, le patient se plain de douleurs majeures sur le membre opéré.

Quelle diagnostic principale par fréquence suspecté ?

- a. **Syndrome des loges**
- b. **Lésions cutanées**
- c. **Fracture occulte**
- d. **Démontage du matériel**
- e. **Plâtre trop lache**



6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

b. Lésions cutanées

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m

Après intubation, et pose d'un pelvic clamp, le patient se stabilise.

Le patient bénéficie d'une ostéosynthèse d'une fracture instable du rachis et de son calcanéum.

Son état s'améliore et il sort enfin des soins intensifs avec une attelle jambièrè postérieure et une décharge totale pour 6 semaines.

Le jour de son retour dans l'unité, le patient se plaint de douleurs majeures sur le membre opéré.

Quelle attitude adopter ? -> ABLATION DU PLATRE ! Evaluation cutané (+ des loges si fractures de jambe). Refaire l'immobilisation !



6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m

Après intubation, et pose d'un pelvic clamp, le patient se stabilise.

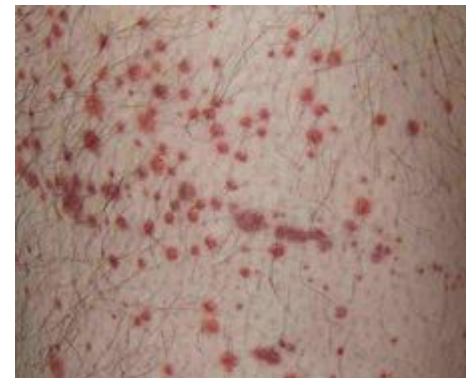
Le patient bénéficie d'un ostéosynthèse d'une fracture instable du rachis et de son calcanéum.

Son état s'améliore et il sort enfin des soins intensifs avec une attelle jambière postérieur et une décharge totale pour 6 semaines.

*Après ablation et réfection d'un plâtre qui présentait des points d'appuis, le patient se sent mieux et retourne à la maison avec des consignes de décharges.

**Lors du contrôle à 1 semaine chez son médecin traitant pour l'antalgie, il présente de nombreux hématome du membre inférieur.
Quel diagnostic évoquer ?**

- a. Lésions de grattages
- b. Necrose cutané
- c. Purpura thrombopénique
- d. Lésions allergiques
- e. Psoriasis



6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

c. Purpura thrombopénique

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m

Après intubation, et pose d'un pelvic clamp, le patient se stabilise.

Le patient bénéficie d'un ostéosynthèse d'une fracture instable du rachis et de son calcanéum.

Son état s'améliore et il sort enfin des soins intensifs avec une attelle jambière postérieur et une décharge totale pour 6 semaines.

Après ablation et réfection d'un plâtre qui présentait des points d'appuis, le patient se sent mieux et retourne à la maison avec des consignes de décharges.

Lors du contrôle à 1 semaine chez son médecin traitant pour l'antalgie, il présente de nombreux hématome du membre inférieur.

Quel diagnostic évoquer ? -> Héparine = surveillance des plaquettes !

Thrombopénie induite à l'héparine ! Arrêt et bilan.



6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m

Après intubation, et pose d'un pelvic clamp, le patient se stabilise.

Le patient bénéficie d'un ostéosynthèse d'une fracture instable du rachis et de son calcanéum.

Son état s'améliore et il sort enfin des soins intensifs avec une attelle jambière postérieur et une décharge totale pour 6 semaines.

Après ablation et réfection d'un plâtre qui présentait des points d'appuis, le patient se sent mieux et retourne à la maison avec des consignes de décharges.

*Après un bilan et une prise en charge d'une TIH à 25 000 plaquettes, le patient à pu poursuivre sa convalescence.

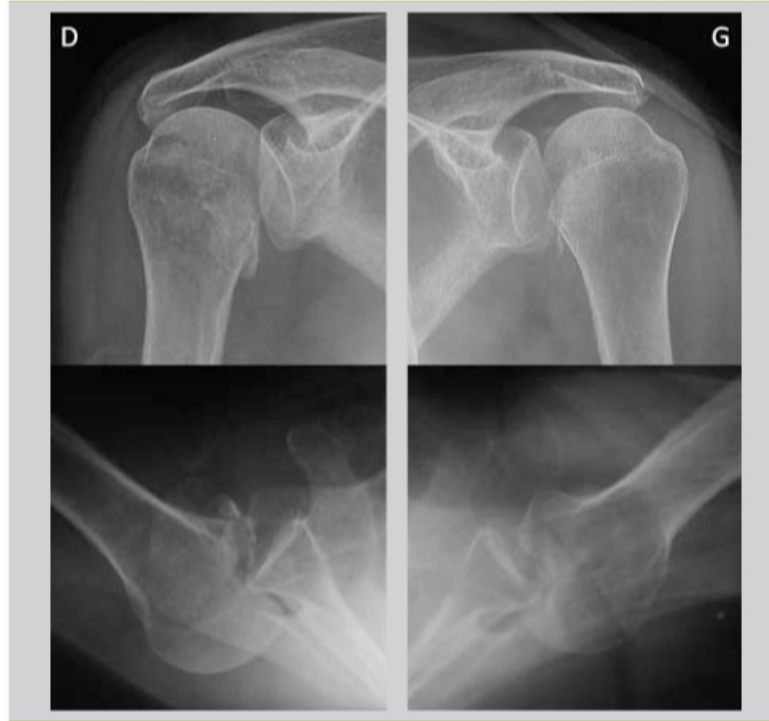
Vous êtes de garde au SU et votre patient et redressé pour nouvelle tentative de suicide. Dans le box il convulse et après une prise en charge intensiviste on vous demande votre avis sur une déformation des 2 membres supérieurs. Quel diagnostic le plus probable évoquer ?

- a. Luxation acromio-claviculaire
- b. Luxation postérieure d'épaule
- c. Luxation antérieure d'épaule
- d. Luxation sterno-claviculaire bilatérale
- e. Fractures de côtes en série



6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

b. Luxation postérieure d'épaule



Vous êtes de garde au SU et votre patient est redressé pour nouvelle tentative de suicide. Dans le box il convulse et après une prise en charge intensiviste on vous demande votre avis sur une déformation des 2 membres supérieurs. Quel diagnostic rechercher ? -> **PREVENTION TERTIAIRE +++ LUXATION POSTERIEUR D'EPAULE DANS LES CRISES D'EPILEPSIES**

6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m

Après intubation, et pose d'un pelvic clamp, le patient se stabilise.

Le patient bénéficie d'un ostéosynthèse d'une fracture instable du rachis et de son calcanéum.

Son état s'améliore et il sort enfin des soins intensifs avec une attelle jambière postérieur et une décharge totale pour 6 semaines.

Après ablation et réfection d'un plâtre qui présentait des points d'appuis, le patient se sent mieux et retourne à la maison avec des consignes de décharges.

Après un bilan et une prise en charge d'une TIH à 25 000 plaquettes, le patient à pu poursuivre sa convalescence.

***Après sa deuxième tentative de suicide et une réduction des deux épaules, ainsi qu'une prise en charge de sa crise d'épilepsie sur sevrage d'OH, votre patient refuse une hospitalisation et menace de récidivé car sa vie et trop dure !**

Quels compléments de prise en charge envisager ?

- a. Demander le consentement
- b. Evaluer le consentement
- c. Demander une hospitalisation à l'aide d'un tiers
- d. Hospitaliser d'office
- e. Garder en surveillance en soins aigue d'orthopédie



6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

d. Hospitaliser d'office

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m

Après intubation, et pose d'un pelvic clamp, le patient se stabilise.

Le patient bénéficie d'un ostéosynthèse d'une fracture instable du rachis et de son calcanéum.

Son état s'améliore et il sort enfin des soins intensifs avec une attelle jambière postérieur et une décharge totale pour 6 semaines.

Après ablation et réfection d'un plâtre qui présentait des points d'appuis, le patient se sent mieux et retourne à la maison avec des consignes de décharges.

Après un bilan et une prise en charge d'une TIH à 25 000 plaquettes, le patient à pu poursuivre sa convalescence.

Après sa deuxième tentative de suicide et une réduction des deux épaules, ainsi qu'une prise en charge de sa crise d'épilepsie sur sevrage d'OH, votre patient refuse une hospitalisation et menace de récidivé car sa vie et trop dure !

Quels compléments de prise en charge envisager ? -> Sd DE SEVRAGE (hyperhydratation, vitaminothérapie, score CIWA, BZD), HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE ! (avis spécialisé)



6. CAS CLINIQUE : une situation complexe...

Patient de 30 ans, dépressif chronique, qui est admis aux urgences pour une défenestration de 10m

Après intubation, et pose d'un pelvic clamp, le patient se stabilise.

Le patient bénéficie d'un ostéosynthèse d'une fracture instable du rachis et de son calcanéum.

Son état s'améliore et il sort enfin des soins intensifs avec une attelle jambière postérieur et une décharge totale pour 6 semaines.

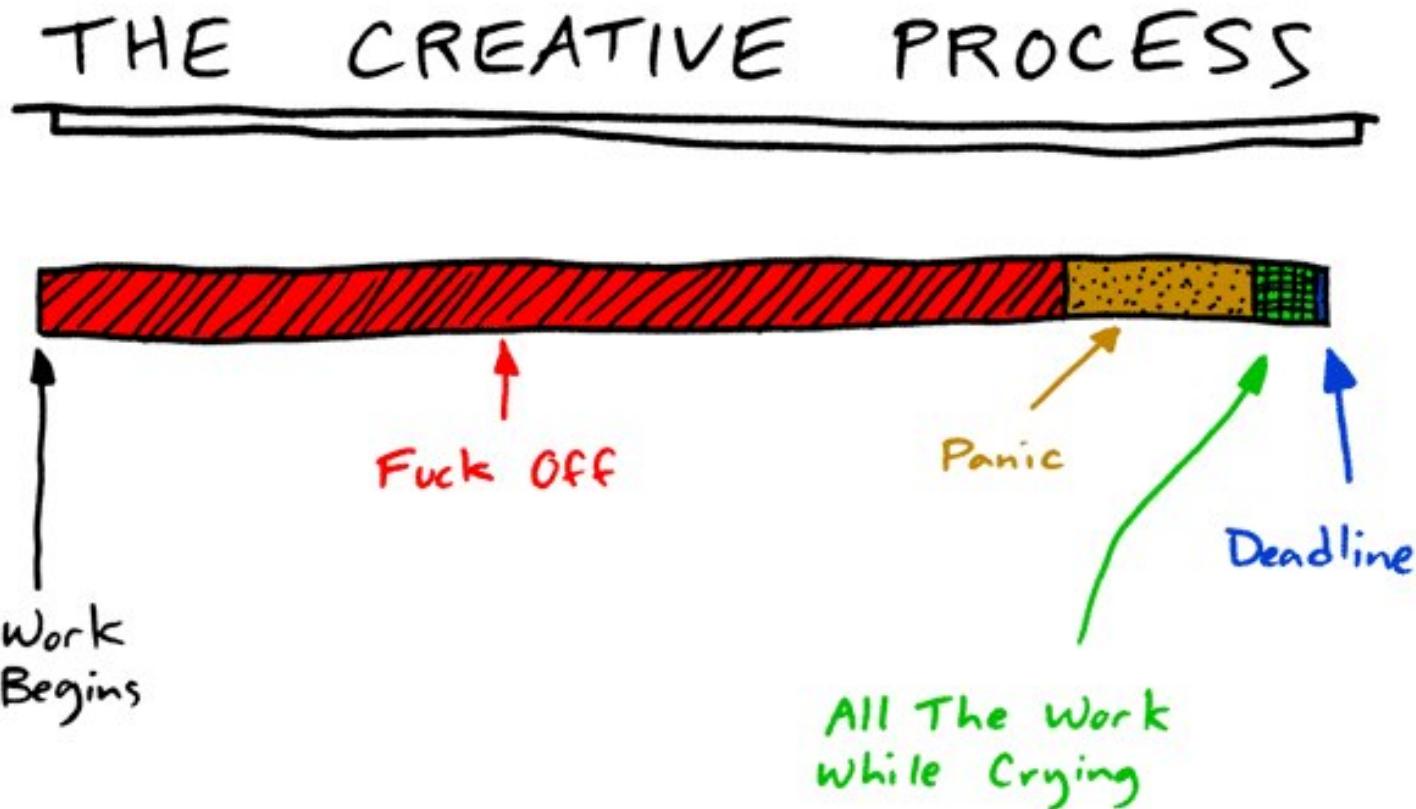
Après ablation et réfection d'un plâtre qui présentait des points d'appuis, le patient se sent mieux et retourne à la maison avec des consignes de décharges.

Après un bilan et une prise en charge d'une TIH à 25 000 plaquettes, le patient à pu poursuivre sa convalescence.

Après sa deuxième tentative de suicide et une réduction des deux épaules, ainsi qu'une prise en charge de sa crise d'épilepsie sur sevrage d'OH, votre patient bénéficie d'un encadrement pour son éthylisme en milieu spécialisé.

Vous le retrouver 13 mois plus tard, en bonne évolution sans séquelles, il a repris une activité professionnelle à 50% dans une animalerie et vous remercie de votre encadrement.





Toothpaste For Dinner.com

Bonnes révisions !!

Ergys GJKA

Unité de Chirurgie de la Main - SCOT

ergys.gjika@hcuge.ch

(+41)79 55 33 179



1.1 Magalie est une jeune fille de **9 ans**. Sa mère vous consulte devant des radiographies osseuses inquiétantes faites lors d'un bilan inhabituel d'âge osseux, complétées par ce **CT**. QUELLE PORPOSITION EST JUSTE SUR LA BASE DE L'EXAMEN ?

a. Benin : limites sont nettes et la corticale est préservée

